

1. Dénomination du médicament

DIACOL

2. Composition qualitative et quantitative

Contient 27 mg de bromhydrate de dextrométhorphan par 15 ml de sirop. Excipients, voir 6.1.

3. Forme pharmaceutique

Sirop.

4. Données cliniques**4.1. Indications thérapeutiques**

Soulagement temporaire de la toux non-productive causée par l'irritation des voies respiratoires supérieures et inférieures.

4.2. Posologie et mode d'administration

On recommande le schéma posologique suivant:

Adolescents, sujets âgés et adultes: 15 ml chaque 6 ou 8 heures. Dose maximale journalière de 60 ml.*Enfants de 2 à 12 ans:* posologie selon indication médicale. Entre les 6 et 12 ans, la dose journalière maximale est de 30 ml et entre les 2 et 6 ans, la dose journalière maximale est de 15 ml.*Enfants âgés moins de 2 ans:* utilisation déconseillée.

DIACOL peut être administré chaque 4 heures, en réduisant la quantité de sirop par prise, de façon à ne pas excéder la dose journalière maximale.

Ne pas excéder les doses recommandées ni utiliser continuellement par des longues périodes.

4.3. Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients du DIACOL. Toux productive. Traitement concomitant avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Utiliser DIACOL avec précaution chez les patients asthmatiques ou atopiques, car il peut promouvoir la libération d'histamine.

Utiliser avec précaution chez les patients manifestant sédation ou débilites.

Chez les patients ayant de l'insuffisance hépatique on peut espérer d'altérations dans son métabolisme.

Si la toux se maintient plus d'une semaine, ou si elle réapparaît ou se fait accompagner de fièvre élevée, éruption cutanée ou céphalées intenses, il faut consulter le médecin.

DIACOL contient 121,64 g de saccharose par 200 ml de sirop. Une dose de 15 ml contient 9,1 g environ de saccharose. Il ne doit pas être utilisé chez les malades ayant d'intolérance héréditaire au fructose, syndrome de malabsorption de glucose-galactose ou déficience de saccharase-isomaltase.

DIACOL contient 2,75 g d'éthanol à 96% par 200 ml de sirop. Une dose de 15 ml contient 0,20 g environ d'éthanol à 96%. Il peut être nuisible pour les patients qui souffrent d'alcoolisme, maladie hépatique, épilepsie, maladie ou traumatisme cérébral, et aussi chez la femme enceinte et enfants. Il peut altérer ou majorer l'effet d'autres médicaments.

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

L'utilisation simultanée de DIACOL et inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO) est contre-indiquée car il peut déclencher des crises adrénurgiques, coma, vertiges, excitabilité, hypertension, hyperpyrexie, hémorragie intracérébrale, léthargie, nausées, comportements psychotiques, spasmes musculaires, tremblement et, éventuellement, mort, et donc l'administration concomitante des deux est contre-indiquée. Il faut respecter une période de 14 jours entre l'arrêt des inhibiteurs de la MAO et l'introduction du dextrométhorphan.

Il faut prendre en compte l'utilisation concomitante des médicaments dépresseurs du système nerveux central car leurs effets peuvent être majorés.

Le risque d'apparition d'effets adverses est accru quand on administre simultanément la quinidine, la fluoxétine, la paroxétine ou la venlafaxine et le DIACOL.

L'utilisation de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool est déconseillée quand on administre simultanément DIACOL.

4.6. Grossesse et allaitement

On n'a pas rapporté des problèmes fœtaux dus à l'utilisation du DIACOL pendant la grossesse et il n'y a pas de données sur l'existence de quelque interférence sur le système reproducteur, mais en tout cas DIACOL n'est pas recommandé au cours de la grossesse et aussi au cours de l'allaitement.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines

Aux doses thérapeutiques, aucune interférence n'est connue.

4.8. Effets indésirables

Les effets indésirables du DIACOL sont rares, se manifestant, parfois, par des troubles légers au niveau du tractus gastro-intestinal, tels que nausées, vomissements, douleurs abdominales, étourdissements et vertiges.

4.9. Surdosage

Les manifestations d'un surdosage sont : nausées, vomissements, vertiges, vision floue, nystagmus, ataxie, rétention urinaire, dépression respiratoire, état de stupeur, psychose toxique (hyperactivité, hallucinations visuelles et auditives) et coma. Le traitement des cas de surdosage utilisera les mesures de support, administration de naloxone par voie parentérale et charbon activé par voie orale et traitement symptomatique.

5. Propriétés pharmacologiques

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Code ATC: R05D A09.

Le dextrométhorphan est un antitussif à action central. Il s'agit d'un isomère du levorphanol, un analogue de la codéine. Par opposition aux autres isomères, le dextrométhorphan est dépourvu de propriétés analgésiques, n'entraîne pas accoutumance ni agit à travers des récepteurs opiacés. Ses propriétés antitussives résultent de son action directe sur le centre médullaire de la toux, augmentant son seuil de sensibilité. Son pouvoir antitussif est semblable à la codéine, se maintenant leur effets pendant 6 heures. Par opposition à la codéine, son action sédatrice est pratiquement négligeable, ne se manifestant qu'avec des doses extrêmement élevées.

À doses thérapeutiques, il n'inhibe pas l'action des cils bronchiques, ce qui peut représenter un avantage quand on le compare avec d'autres agents antitussifs.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Le dextrométhorphan est rapidement absorbé au niveau gastro-intestinal. Le t_{max} est de 2 à 2,5 heures et la C_{max} après une dose orale de 60 mg est de 5,2 ng/mL. L'effet antitussif s'observe 15 à 30 minutes après l'administration et se prolonge pendant 5 à 6 heures.

Le dextrométhorphan se distribue dans le SNC, atteignant des concentrations détectables dans le liquide céphalo-rachidien (LCR). Dans des études chez l'animal on a démontré des relations de concentration LCR/plasma, oscillant entre 32,8 et 80%.

Le dextrométhorphan subit une rapide et extensive métabolisation hépatique, originant un métabolite actif (dextorphan) et deux inactifs (3-méthoxymorphinan et morphinan-3-1). Le dextrométhorphan est métabolisé par l'isoenzyme CYP2D6, subissant déméthylation oxydative.

Le dextrométhorphan et ses métabolites déméthylés sont excrétés par voie urinaire. La demi-vie d'élimination plasmatique du dextrométhorphan est de 1,4 à 3,9 heures et du dextorphan de 3,4 à 5,6 heures.

5.3. Données de sécurité précliniques

Le dextrométhorphan est un médicament à usage courant, inclus pratiquement en toutes les pharmacopées.

6. Données pharmaceutiques

6.1. Liste des excipients

Saccharose, acide citrique anhydre, méthylparaben, arôme d'orange liquide, éthanol à 96 pour cent et eau purifiée.

6.2. Incompatibilités

En l'absence d'études d'incompatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.

6.3. Durée de conservation

3 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Boîte de carton contenant un flacon de verre, couleur ambre, type III, et une littérature. Le flacon contient 200 ml de sirop. L'emballage contient un godet.

6.6. Précautions particulières d'élimination

Pas d'exigences particulières.

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.